

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage 3 - Influenza –Präventions– und Bekämpfungsplan“	

aupziel innerhalb unseres Leitbildes ist es, dass sich Patienten in unserer Betreuung wohlfühlen. Dies bedeutet für uns auch, durch unser Handeln den Patienten nicht zu gefährden bzw. ihn in seiner gesundheitlichen Situation weiter zu stabilisieren. Hier eingebunden ist vor allem der geordnete und bewusste Umgang mit Hygiene, Desinfektion und Infektionsschutz.

Die nach stehenden Regelungen unseres „Influenza Präventions- bzw. Bekämpfungsplanes“ lehnen sich an folgende Dokumente an:

- Rahmenhygieneplan für Pflegedienste Stand: 05/2003 (Verfasser: Landesgesundheitsamt Brandenburg, Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern , Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen, Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz)
- Empfehlungen des RKI zu Hygienemaßnahmen bei Patienten mit Verdacht auf bzw. nachgewiesener Influenza, Stand: Stand: 25.08.2006

Begriffsbestimmungen/Definitionen

Influenza

Die **Influenza**, auch „echte“ **Grippe** genannt, ist eine durch Viren aus den Gattungen Influenzavirus A oder B ausgelöste Infektionskrankheit bei Menschen, anderen Säugetieren und Vögeln. Im Volksmund wird die Bezeichnung Grippe häufig für grippale Infekte verwendet, bei denen es sich aber um verschiedene, in der Regel deutlich harmloser verlaufende Viruserkrankungen handelt.

Pandemie

Unter **Pandemie** versteht man den länderübergreifenden oder sogar weltweiten Ausbruch einer Krankheit .Im Gegensatz zur Epidemie ist eine Pandemie nicht örtlich beschränkt.

Das bedeutet, dass eine Pandemie die ganze Weltpopulation betreffen kann und nicht an den Grenzen eines Landes oder eines Kontinents Halt macht.

Wir verstehen unser Handeln im Sinne des geltenden Nationalen Influenza-Pandemieplanes.

Infektionsweg

Die Übertragung von Influenzaviren erfolgt vermutlich überwiegend durch Tröpfchen, die relativ groß sind ($> 5 \mu\text{m}$), z.B. beim Sprechen, insbesondere aber beim Husten oder Niesen entstehen und über eine geringe Distanz auf die Schleimhäute von Kontaktpersonen gelangen können. Einzelne Publikationen legen aber auch die Möglichkeit einer Übertragung durch so genannte Tröpfchenkerne nahe, die kleiner sind ($< 5 \mu\text{m}$) und länger in der Luft schweben können (aerogene Übertragung). Darüber hinaus kann die Übertragung auch durch direkten Kontakt der

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage 3 - Influenza –Präventions– und Bekämpfungsplan“	

Hände zu mit virushaltigen Sekreten kontaminierten Oberflächen und anschließendem Hand-Mund/Hand-Nasen-Kontakt erfolgen (z.B. durch Händeschütteln). Der Erreger ist als behülltes Virus gegen schädigende Umwelteinflüsse relativ empfindlich, in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen (z.B. Feuchtigkeit und Temperatur) kann er allerdings über mehrere Stunden, bei niedrigen Temperaturen (z.B. < 20 °C) in Wasser auch deutlich länger (bis zu einigen Monaten), persistieren.

Inkubationszeit

1–3 Tage

Dauer der Ansteckungsfähigkeit

Eine Ansteckungsfähigkeit beginnt bereits kurz (< 24 Stunden) vor Auftreten der klinischen Symptomatik und besteht danach gewöhnlich für 3–5 Tage. Kleine Kinder können Viren früher und für längere Zeit als Erwachsene ausscheiden.

Symptome

Die **Influenza-typische Symptomatik** ist durch

- plötzlichen Erkrankungsbeginn mit Fieber ($\geq 38,5$ °C)
- trockenen Reizhusten
- Muskel- und/oder Kopfschmerzen gekennzeichnet.

Weitere Symptome können allgemeine Schwäche, Schweißausbrüche und Halsschmerzen sein. Die **schwersten Verlaufsformen** sind der perakute Todesfall innerhalb weniger Stunden und die primäre Influenzapneumonie. Auch Enzephalitiden und Myokarditiden kommen vor.

Komplikationen treten vor allem bei älteren Personen mit Grundkrankheiten (chronische Herz- oder Lungen-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie z.B. Diabetes, Immundefekte usw.) auf. Bei ihnen können sich insbesondere Pneumonien durch bakterielle Superinfektion (Pneumokokken, Staphylokokken) entwickeln.

Für unseren Pflegedienst legen wir bis auf Weiteres Folgendes zur Prävention bzw. Bekämpfung von Influenzaviren fest:

Maßnahmen der Prävention

- 1) Prävention geht vor Bekämpfung von akutem Virenbefall.
- 2) Alle Mitarbeiter sind beim Umgang mit erkrankten Patienten bzw. dem Erkennen von Symptomen zu schulen.
- 3) Erkrankte Mitarbeiter sind von pflegerischen Tätigkeiten fernzuhalten. Klagt ein Mitarbeiter über oben dargestellte Symptome, so hat er umgehend den Arzt aufzusuchen. Innerhalb eines Attestes soll der Arzt feststellen, ob eine pflegerische Tätigkeit ausgeführt werden kann.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage 3 - Influenza –Präventions– und Bekämpfungsplan“	

- 4) Jeder Mitarbeiter hat die Vorgaben von Hygiene und Desinfektion im Sinne des gültigen Rahmenhygieneplanes bzw. unseres freigegebenen Hygieneplanes zu kennen und bewusst in der täglichen Praxis umzusetzen. Unser Ziel ist es, vor allem durch Umsetzung von Händehygiene und -desinfektion, dem Tragen von Einmalhandschuhen und Mundschutz die Infektionskette wirksam zu unterbrechen.
- 5) Der Mitarbeiter hat bei der Umsetzung von Pflegemaßnahmen wie folgt vorzugehen: Mund-Nasen-Schutz /Schutzkittel vor Betreten des Zimmers anlegen und dort bei Verlassen zurücklassen, Einweghandschuhe bei Betreten des Zimmers anlegen und vor Verlassen des Zimmers in geschlossenem Behältnis entsorgen, Händedesinfektion im Sinne des Hygieneplanes umsetzen.
- 6) Soweit, unter Berücksichtigung des Selbstbestimmungsrechtes, möglich sollten im Rahmen der Prävention Schutzimpfungen gegen den aktuellen Influenzavirus angeboten und umgesetzt werden. Schutzimpfungen sind wichtiger Bestandteil unserer Prävention – unsere Patienten sind von der Notwendigkeit zu überzeugen, wir arbeiten mit der biografisch positiven Erfahrung unserer Patienten, die Schutzimpfungen schon von früher her kennen.
- 7) Zur geordneten Umsetzung von Schutzimpfungen stimmen wir uns mit dem Hausarzt bzw. den Gesundheitsämtern ab.
- 8) Ausdrücklich sollen sich auch Mitarbeiter im Rahmen von Schutzimpfungen gegen mögliche Infektionen schützen (Pkt. 5.3 Rahmenhygieneplan).

Maßnahmen der Bekämpfung von Influenzaerkrankungen

- 1) Jeder Mitarbeiter hat besonders auf mögliche Erkrankungssymptome bei unseren Patienten zu achten.
- 2) Alle Mitarbeiter beachten die erheblichen Auswirkungen von Influenzaerkrankungen unserer Patienten unter Beachtung teilweiser stark beeinträchtigter Lebensqualität, eines herabgesetzten Immunsystems und stark geschwächter körperlicher Konstitution.
- 3) Bei Auftreten der vorgenannten Symptome hat der Mitarbeiter sofort den Hausarzt zu informieren, der die Therapie selbstverantwortlich führt.
- 4) Im Rahmen der therapeutischen Betreuung durch den Arzt achten wir auf die ordnungsgemäße Umsetzung ärztlicher Festlegungen.
- 5) Die Angehörigen sind über die Erkrankung zu informieren.
- 6) Gemeinschaftsaktivitäten mit erkrankten Patienten sind einzuschränken.
- 7) Die betroffenen Patienten sind bei Hustenattacken mit Papiertaschentüchern auszustatten.
- 8) Flächendesinfektion von patientennahen Flächen als auch für Geräte und Medizinprodukte hat mit einem Desinfektionsmittel mit der Kennzeichnung „begrenzt viruzid“ zu erfolgen.
- 9) Der Bereich Reinigung ist über die o.g. Besonderheiten zu informieren und hat diese Besonderheiten in der täglichen Praxis zu berücksichtigen.
- 10) Lässt sich ein Krankentransport des erkrankten Patienten nicht vermeiden, ist der Fahrer über die Erkrankung zu informieren.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage 3 - Influenza –Präventions– und Bekämpfungsplan“	

- 11) Bei Verstorbenen aufgrund der Influenza ist darauf zu achten, dass auch durch den Verstorbenen Viren weiter verbreitet werden können. Die Vorgaben zum Umgang mit Leichen in unserem Pflegedienst sind zu berücksichtigen. Ein Kontakt mit Sekreten ist zu vermeiden, der Sarg ist zu kennzeichnen und das Gesundheitsamt zu informieren. Soweit möglich erfolgt das Einsargen ohne Ausführung weiterer Tätigkeiten nach Abschiednahme durch Angehörige.
- 12) Treten Erkrankungen gehäuft auf bzw. werden Erkrankungen als nosokomial (aus dem Krankenhaus kommend) gekennzeichnet, erfolgt eine Information durch die PDL an das Gesundheitsamt. Mit dem Gesundheitsamt ist sich über den weiteren Verlauf abzustimmen.
- 13) Eine Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen erfolgt auf den Nachweisen – Pflegebericht/Ärztliche Verordnung/Medikamentenblatt/Pflegeplanungsblatt, etc.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	4	Verw./MA